# RUTA INSTITUCIONAL: INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE)



En Hospital Regional de Moniquirá E.S.E
**Hasta Semana 15 de Gestación**

Según lineamientos de:
Resolución 051 del 2023
Sentencia C- 055 del 2022 (antes de la semana 24)

Si > 15 semanas → **REMISIÓN III NIVEL PRIORITARIO**

Si > 24.6 semanas y solicita IVE → Revisar causales de sentencia C- 355 de 2006 y REALIZAR remisión III nivel

- Cuando el embarazo constituye un peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico
- Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificado por un médico.
- Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal violento, acto sexual sin consentimiento, abusos sexuales o incesto.

¿Cómo inicia?

Solicitud de gestante en consulta externa, urgencias y/o Ginecología/Obstetricia

Iniciar la ruta inmediatamente **(plazo máximo de 5 días para respuesta de solicitud)** → **Ruta activación IVE**

Si la solicitud fue realizada en:

- Consulta externa → Remitir a urgencias de ginecología
- Urgencias → Remitir a urgencias de ginecología **COMENTAR TELEFÓNICAMENTE SIN INDICAR INTERCONSULTA**

**IVE siempre es una URGENCIA**

**Psicología:** Disponible si se requiere, **no obligatoria**. Se solicita según criterio médico, sin generar barreras para la atención.

**< 14 años** → **Activación Código Verde**

- Requiere firma de asentimiento pediátrico para IVE (NO requiere que firmen los padres para que la menor de 14 acceda a la IVE ). **PERO**, si requiere AMEU o anestesia se requiere consentimiento de padres o adulto responsable ( si la paciente no desea que su familia sepan de IVE se debe realizar un consentimiento sustituto por parte de la institución)

**> = 14 años**

**Anamnesis y antecedentes**

- Documentar antecedentes relevantes.
- Evaluar historia reproductiva, sintomatología actual y uso previo de anticonceptivos.
- Registrar claramente la solicitud de IVE y la edad gestacional estimada.
- Indagar condiciones psicosociales: tensión emocional, estado de ánimo, síntomas neurovegetativos y redes de apoyo.
- En gestaciones mayores a 24 semanas, valorar la afectación emocional/social para identificar causales contempladas en la Sentencia C-355 de 2006.

**Examen físico**

- Realizar examen físico general completo.
- Confirmar la existencia del embarazo y estimar la edad gestacional mediante examen pélvico bimanual o medios paraclínicos disponibles.
- Evaluar discrepancias entre edad gestacional y tamaño uterino

**Paraclínicos**

- **NO exigir paraclínicos como requisito para IVE**
- Solicitar cuadro hemático si se sospecha clínicamente anemia.
- Conocer la hemoclasificación e indicar inmunoglobulina anti-D en mujeres Rh negativas.
- Ofrecer tamizaje para VIH y sífilis, explicando que son voluntarios y no condicionan el procedimiento.
- En caso clínicamente justificado, realizar ecografía para descartar embarazo ectópico u otras patologías. Informar a la mujer sobre su derecho a no visualizar la imagen ecográfica, salvo que así lo desee.

## 4 pasos clave del médico tratante:



**1** Asesoría y orientación en la consulta inicial → Brindar información clara y comprensible sobre las opciones disponibles: IVE, continuación del embarazo, y adopción.

Si el profesional se declara objetor de conciencia, debe remitir de forma inmediata a otro profesional garantizando la continuidad y oportunidad en la atención

**2** Diligenciar y firmar consentimiento informado → **Consentimiento informado que incluya**: opciones de tratamiento y sus implicaciones, riesgos, ventajas y duración de cada opción, qué esperar antes, durante y después del procedimiento, signos de alarma, información sobre retorno de la fertilidad, inicio de relaciones sexuales y anticoncepción postevento.

**3** Elección Método IVE





**Antes semana 12: AMBULATORIO**

1. Iniciar con 200 mg de mifepristona administrados de manera oral, a las 24 horas de administrada la mifepristona se indica manejo con 800 mcg de misoprostol vía vaginal, sublingual o bucal en dosis única. * Como mínimo deben pasar 24 horas entre la administración de la mifepristona y del misoprostol.*

2. En caso de contar únicamente con misoprostol, se pueden utilizar 800 mcg de misoprostol en dosis única suministrados por vía bucal, sublingual o vaginal y teniendo en cuenta que la probabilidad de requerir un procedimiento adicional o complementario aumenta de 1-2% con el tratamiento combinado a 15-10% con solo misoprostol

**Semana 12 a 15: HOSPITALARIO**

1. Dosis inicial de 200 mg de mifepristona administrados de manera oral , a las 24 horas posterior a la administración de la mifepristona , administrar 400 mcg de misoprostol de manera vaginal, sublingual o bucal, cada tres horas bajo observación directa hasta la expulsión . *Como mínimo deben pasar 24 horas entre la administración de la mifepristona y del misoprostol*

**RÉGIMEN MISOPROSTOL SOLO**

- < 13 semanas: 800 mcg sublingual cada 3 horas o vaginal/bucal cada 3 a 12 horas (2 a 3 dosis)
- 13 a 24 semanas: 400 mcg vía vaginal, sublingual o bucal cada 3 horas

**AEU- AMEU**

**Hasta la semana 15 de gestación**

Se requiere preparación del cérvix previa al AMEU, con misoprostol cuando no es posible realizar la dilatación con los dilatadores mecánicos, en adolescentes, embarazos de más de 12 semanas o cuando exista riesgo aumentado de una laceración cervical así: 400mcg vía vaginal 3 horas antes de la evacuación o 400 mcg sublingual 400 2 horas antes de la evacuación

**Indicar analgésico antes y después**

**Indicar antibióticos : Doxiciclina oral 500 mg antes del procedimiento ó Doxiciclina 100 mg 1 hora antes del procedimiento y 200 mg 1 hora y media después**

**4** Seguimiento posterior procedimiento → Ofrecer consejería en anticoncepción, indicar cuándo retomar actividades normales, incluidos los aspectos sexuales y realizar valoración de síntomas persistente/seguimiento emocional.

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E
*Crecemos para cuidar tu Salud!*